EDIÇÃO Nº 0 · AMOSTRA EDITORIAL

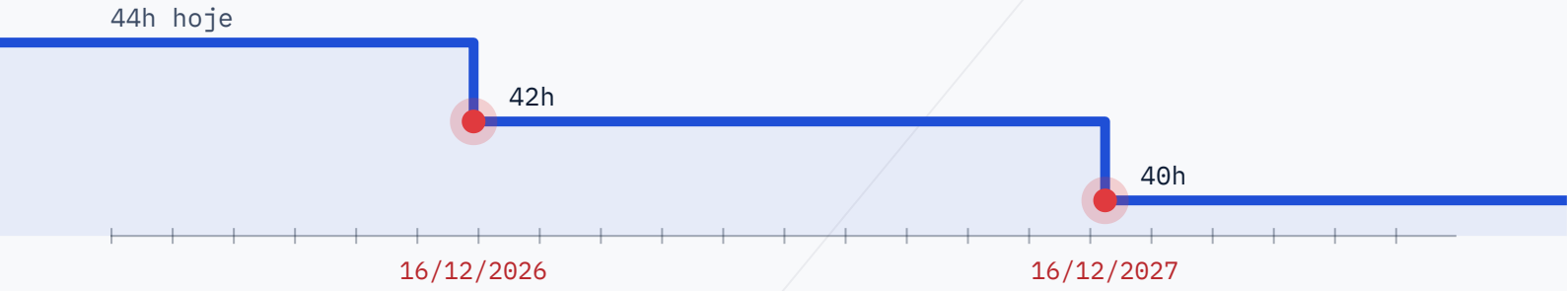
17 DE OUTUBRO DE 2026

RADAR ODONTO

Ciência, regulamentação e gestão para decisões mais bem informadas na Odontologia.

01 · RADAR REGULATÓRIO · JORNADA MÁXIMA A PARTIR DE 16/12/2026

42h



Fim da escala 6×1: a jornada muda em dezembro

PRÓXIMO PRAZO
30/10

Opção pelo regime regular de IBS e CBS por empresas do Simples p. 2

NESTA EDIÇÃO

01 Radar regulatório — Escala 6×1, sedação, PMMA e CEOF — p. 3

02 Ciência que informa a conduta — Antibióticos sistêmicos na peri-implantite — p. 7

03 Gestão da clínica — Reforma tributária antes de novembro — p. 9

04 O dentista — Distúrbios musculoesqueléticos — p. 11

05 Comércio odontológico — Três movimentos para as dentais — p. 12

06 Ferramenta da edição — Sua equipe e a nova jornada — p. 13

07 Encarte Radar GOV Indústria — Anvisa revisa o reúso de dispositivos — p. 14

Eduardo Vieira Zanetti

Nesta edição

A Odontologia brasileira entra no último trimestre de 2026 diante de mudanças que afetam a organização das clínicas, a tributação dos serviços, a habilitação profissional e a cadeia de produtos para saúde.

A redução da jornada semanal já foi promulgada. A reforma tributária traz decisões com prazo ainda neste mês. As regras para sedação odontológica enfrentam uma suspensão judicial parcial. E a Anvisa abriu uma discussão que poderá modificar as exigências de processamento e regularização de dispositivos médicos.

Na literatura científica, revisões recentes reacenderam o debate sobre antibióticos sistêmicos na peri-implantite, mas seus resultados ainda não justificam uma alteração indiscriminada dos protocolos clínicos.

Agenda de atenção

OUT 2026 → JAN 2027

30/10/2026	Opção pelo regime regular de IBS e CBS por empresas do Simples	Prazo oficial
01/11/2026	NFS-e nacional para ME e EPP do Simples prestadoras de serviços	Obrigação regulamentada
16/12/2026	Jornada máxima de 42 horas semanais e dois repousos	Transição constitucional
01/01/2027	Nova etapa das regras de CBS e IBS aplicáveis ao Simples	Início de vigência
27/01/2027	Habilitação em sedação por experiência	Data calculada; confirmar com o CRO
28/01/2027	Consultas públicas da Anvisa sobre processamento de dispositivos	Prazo de participação

Radar regulatório · Gestão da clínica · Radar GOV Indústria

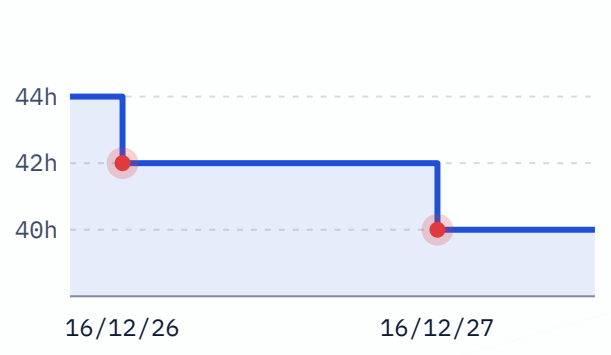
As datas foram apuradas com referência aos atos e comunicados disponíveis até 17/10/2026. Situações judiciais e administrativas podem ser modificadas.

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6×1: a jornada muda em dezembro

O Congresso Nacional promulgou, em 16 de outubro de 2026, a **Emenda Constitucional nº 141**, originada da PEC 221/2019, que reduz progressivamente a jornada semanal máxima de trabalho e estabelece dois dias de repouso semanal remunerado, um deles preferencialmente aos domingos.

A implementação ocorrerá em duas etapas:



16 de dezembro de 2026: a jornada normal máxima passa de 44 para 42 horas semanais, e entram em vigor as novas disposições sobre repouso semanal.

16 de dezembro de 2027: a jornada normal máxima passa para 40 horas semanais.

A redução não poderá resultar em diminuição salarial nominal ou proporcional, inclusive dos pisos.

A emenda admite, em condições específicas, regimes compensatórios mediante acordo ou convenção coletiva. Durante a transição, a negociação coletiva também poderá disciplinar a distribuição diária das 42 horas. Não se trata, portanto, de autorização irrestrita para aumentar o expediente diário.

Impacto para a clínica

Consultórios que funcionam aos sábados precisarão reavaliar a cobertura de recepção, auxiliares e técnicos em saúde bucal, esterilização e atividades administrativas.

O custo dependerá da escala atual, dos serviços oferecidos e da necessidade de manter atendimento em seis dias da semana.

O que fazer agora: levantar a jornada efetiva de cada empregado, consultar a convenção coletiva aplicável e simular alternativas de funcionamento, revezamento e contratação. A definição deve ocorrer antes da primeira etapa de vigência.

Fonte oficial: Emenda Constitucional nº 141/2026 — Presidência da República, especialmente arts. 2º, 3º, 6º, 7º e 10.

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Sedação odontológica: nova regulamentação, prazo de habilitação e suspensão judicial

A **Resolução CFO nº 295/2026** reorganizou as regras para o emprego de fármacos na sedação odontológica, definindo requisitos de formação, habilitação, monitorização, segurança e responsabilidade profissional.

A regulamentação estabelece duas modalidades formativas:

200 h **Habilitação básica:** formação mínima de 200 horas, observados os requisitos curriculares da resolução.

500 h **Habilitação avançada:** formação mínima de 500 horas, com pelo menos 60% de atividades práticas presenciais supervisionadas e requisitos próprios de ingresso.

A norma também estabelece exigências relacionadas à avaliação pré-sedação, consentimento informado, monitorização, equipamentos de emergência, registro em prontuário e capacidade de reconhecimento e manejo da progressão inadvertida da sedação.

Reconhecimento por experiência: quem pode solicitar?

A Resolução 295 prevê o reconhecimento da habilitação básica por experiência profissional, desde que sejam comprovados **cumulativamente** os requisitos do art. 39:

1. Cadastro prévio de habilitação em analgesia relativa ou sedação consciente com óxido nitroso no Sistema CFO/CROs.
2. Certificação atualizada, obtida nos últimos dois anos, de Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado de Vida para a Odontologia, ou equivalente.
3. Atuação clínica efetiva documentada por memorial de casos.
4. Formação, ensino ou participação em atividades relacionadas à sedação.
5. Ausência de condenação ética relacionada à prática de sedação.

104 h

A norma exige que a comprovação de prática clínica e formação totalize **104 horas**, atribuindo uma hora a cada caso clínico documentado e computando a carga horária pertinente dos cursos e eventos.



O requerimento deverá ser apresentado ao CRO de inscrição principal dentro de 180 dias da publicação. Considerando a publicação no Diário Oficial da União de **31 de julho de 2026**, a data calculada para encerramento é **27 de janeiro de 2027**.

Continua na p. 5 →

SEDAÇÃO ODONTOLÓGICA · CONTINUAÇÃO

A comprovação de experiência isoladamente, sem os demais requisitos, não assegura o reconhecimento da habilitação.

O que foi suspenso pela Justiça?

Em decisão de 6 de agosto de 2026, divulgada oficialmente pelo CFO em 24 de agosto, a Justiça Federal suspendeu parcialmente os dispositivos da Resolução nº 295 que autorizam, regulamentam ou viabilizam a execução de **sedação profunda** por cirurgiões-dentistas.

A medida também alcançou a concessão e o registro de cursos e habilitações avançadas destinados a essa finalidade.

A decisão não suspendeu integralmente a resolução. Segundo o esclarecimento institucional do CFO, permanecem preservadas as disposições sobre sedação mínima e moderada, inclusive os requisitos de segurança pertinentes.

O processo judicial ainda está sujeito a novos desdobramentos.

SITUAÇÃO DA RESOLUÇÃO 295

Suspenso

Sedação profunda por cirurgiões-dentistas

Cursos e habilitações avançadas para essa finalidade

decisão de 06/08/2026

Preservado

Sedação mínima e moderada

Requisitos de segurança pertinentes

segundo o CFO, 24/08/2026

O que fazer agora: conferir a situação cadastral perante o CRO, examinar a elegibilidade para reconhecimento por experiência, reunir documentos e verificar os protocolos assistenciais e a infraestrutura necessária. Profissionais interessados na habilitação avançada devem acompanhar a situação judicial antes de realizar investimentos ou presumir autorização para sedação profunda.

FONTES OFICIAIS

Resolução CFO nº 295/2026 — texto integral, especialmente arts. 39–41 e 55–59.

CFO — esclarecimento sobre a decisão judicial de 24/08/2026.

MATERIAIS E PROCEDIMENTOS

PMMA: uso exclusivamente estético está proibido

A **Resolução CFO nº 297/2026** proibiu o uso do polimetilmetacrilato (PMMA) como substância preenchedora injetável em procedimentos exclusivamente estéticos no exercício da Odontologia.

O emprego do material permanece limitado às indicações reparadoras admitidas pela Anvisa, observadas as condições aprovadas no registro sanitário, a habilitação técnica específica e os limites de finalidade, quantidade e técnica.

A regulamentação exige informação prévia sobre riscos, benefícios, alternativas e caráter permanente do material, mediante consentimento esclarecido. Também determina a rastreabilidade do produto utilizado.

O descumprimento pode configurar infração ético-disciplinar, sem prejuízo de outras responsabilidades legais.

> **O que fazer:** revisar a indicação dos procedimentos, conferir registros sanitários, atualizar termos de consentimento e retirar o PMMA de qualquer oferta com finalidade exclusivamente estética.

Fonte: CFO — Resolução nº 297/2026 e orientações sobre PMMA.

TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA

Cirurgia Estética Orofacial: questionamento legislativo permanece em tramitação

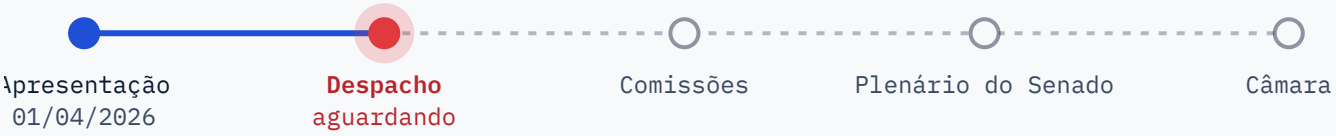
O **Projeto de Decreto Legislativo nº 177/2026** pretende sustar as Resoluções CFO nº 283 a 286/2026, que tratam de aspectos da atuação profissional, incluindo a Cirurgia Estética Orofacial.

Segundo a ficha de tramitação do Senado Federal, a proposição permanecia aguardando despacho desde 1º de abril de 2026.

É necessário distinguir a apresentação de uma proposta legislativa de sua eventual aprovação. A existência do PDL, isoladamente, não revoga nem suspende os atos normativos questionados.

> **O que acompanhar:** o andamento legislativo, manifestações oficiais do CFO e eventuais decisões judiciais que afetem a aplicação das resoluções.

CAMINHO PREVISTO DO PDL 177/2026



Fonte: Senado Federal — PDL 177/2026.

Também no radar

A Portaria CFO-SEC nº 173/2026, publicada em 5 de outubro, designou representantes do CFO na COSAÚDE, comissão da Agência Nacional de Saúde Suplementar relacionada à atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde.

IMPLANTODONTIA · PERI-IMPLANTITE

Antibióticos sistêmicos na peri-implantite: benefício limitado, indicação ainda controversa

MAPA DA EVIDÊNCIA

- **2023** — **Diretriz S3 · EFP**
  Contra o uso rotineiro
- **2025** — **Antonoglou et al. · J Clin Periodontol**
  Benefício de curto prazo, de um a dois anos
- **2026** — **Isola et al. · Periodontology 2000**
  Menos sangramento e profundidade aos 12 meses

SÍNTESE PARA A PRÁTICA

Existe sinal de benefício em alguns desfechos, mas a prescrição rotineira de antibióticos sistêmicos na peri-implantite não encontra sustentação adequada nas diretrizes atuais.

Duas revisões sistemáticas recentes trouxeram novos elementos ao debate sobre o emprego de antibióticos sistêmicos como adjuvantes no tratamento da peri-implantite.

A primeira, de Isola e colaboradores, publicada eletronicamente em abril de 2026 na *Periodontology 2000*, reuniu 18 estudos na análise qualitativa, dos quais nove ensaios clínicos randomizados puderam integrar a meta-análise.

Nos casos de peri-implantite tratados por abordagens cirúrgicas e não cirúrgicas, os antibióticos sistêmicos foram associados a reduções estatisticamente significativas do sangramento à sondagem e da profundidade de sondagem aos 12 meses.

Entretanto, os autores não identificaram melhora consistente do nível ósseo marginal. Na mucosite peri-implantar, não houve benefício adicional significativo dos antibióticos nos desfechos clínicos avaliados.

A heterogeneidade dos protocolos e a limitação dos dados de longo prazo reduzem a segurança das conclusões.

O que mostrou a segunda revisão?

Antonoglou e colaboradores publicaram, em 2025, uma revisão com meta-análises envolvendo sete estudos — três randomizados e quatro não randomizados —, totalizando 595 pacientes e 1.388 implantes.

Os resultados sugeriram benefícios de curto prazo, de aproximadamente um a dois anos, em determinados desfechos do tratamento cirúrgico da peri-implantite.

Os sinais de benefício foram mais evidentes em implantes com superfícies modificadas. Contudo, não se observaram vantagens substanciais em acompanhamentos de três anos ou mais, e os dados sobre eventos adversos foram limitados.

Continua na p. 8 →

PERI-IMPLANTITE · CONTINUAÇÃO

Uma associação favorável em subgrupos não estabelece, por si só, critérios definitivos de prescrição.

O que dizem as diretrizes clínicas?

A diretriz S3 da **Federação Europeia de Periodontologia (EFP)**, publicada em 2023, recomenda contra o emprego rotineiro de antibióticos sistêmicos como adjuvantes do tratamento não cirúrgico da peri-implantite.

Para o tratamento cirúrgico, a recomendação é contrária ao uso adjuvante, considerando as incertezas sobre benefício, os possíveis eventos adversos e o problema coletivo da resistência antimicrobiana.

As revisões mais recentes oferecem resultados que merecem análise e discussão, mas ainda não justificam abandonar essas recomendações.

É importante diferenciar melhora estatística em parâmetros clínicos intermediários de benefício sustentável na resolução da doença, na manutenção óssea e na sobrevida dos implantes.

Aplicação clínica

O tratamento continua fundamentado no controle do biofilme, na instrumentação e descontaminação apropriadas, na correção de fatores locais modificáveis, na avaliação da necessidade de intervenção cirúrgica e no acompanhamento peri-implantar.

Eventuais indicações excepcionais de antibioticoterapia sistêmica devem resultar de avaliação clínica individualizada, com análise de riscos, alternativas e justificativa documentada.

SÍNTESE PARA A PRÁTICA

Existe sinal de benefício em alguns desfechos, mas a prescrição rotineira de antibióticos sistêmicos na peri-implantite não encontra sustentação adequada nas diretrizes atuais.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS

Isola G et al. *Impact and efficacy of systemic antibiotics for peri-implant diseases treatment: A systematic review and meta-analysis on clinical and microbiological outcomes.* Periodontology 2000, vol. 99, p. 284–310. DOI: 10.1111/prd.70033.

Nota bibliográfica: o periódico associa o artigo ao volume de 2025, mas informa primeira publicação eletrônica em 01/04/2026.

Antonoglou GN et al. *Do Systemic Antibiotics Offer Benefits to the Surgical Treatment of Peri-Implantitis? A Systematic Review With Meta-Analyses.* Journal of Clinical Periodontology. 2025;52:1746–1759. DOI: 10.1111/jcpe.70021.

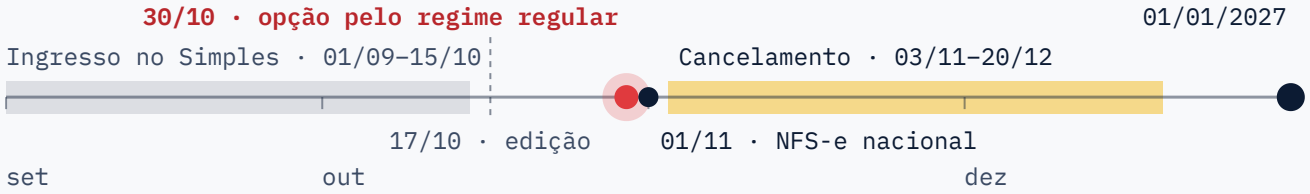
Herrera D et al. *Prevention and treatment of peri-implant diseases—The EFP S3 level clinical practice guideline.* Journal of Clinical Periodontology, 2023. DOI: 10.1111/jcpe.13823.

TRIBUTAÇÃO

Reforma tributária: o que precisa ser decidido antes de novembro

A reforma tributária do consumo entra em nova etapa em 2027. Para clínicas odontológicas, há três assuntos que exigem atenção: a escolha de regime para IBS e CBS, a emissão da NFS-e nacional e a correta classificação dos serviços de saúde.

Simples Nacional: duas opções que não devem ser confundidas



A Receita Federal distinguiu dois procedimentos para 2027.

O prazo de ingresso ou retorno ao Simples Nacional ocorreu entre **1º de setembro e 15 de outubro de 2026**. Contribuintes que solicitaram ingresso e apresentaram pendências impeditivas têm prazo específico de regularização até 30 de outubro.

Já as empresas que estão no Simples e pretendem **apurar e recolher IBS e CBS pelo regime regular**, fora do DAS, podem realizar essa opção até **30 de outubro de 2026**, com efeitos para o primeiro semestre de 2027.

A Receita também estabeleceu a possibilidade de cancelamento dessas opções entre **3 de novembro e 20 de dezembro de 2026**.

A escolha do regime regular de IBS e CBS não deve ser confundida com o abandono integral do Simples Nacional. Ela possui efeitos específicos sobre a apuração desses tributos.

> **O que fazer agora:** solicitar à contabilidade uma simulação comparando o recolhimento dentro do DAS e pelo regime regular, considerando o perfil de clientes, créditos, custos e margem da clínica.

Nota fiscal: a obrigação começa antes de 2027

A **Resolução CGSN nº 191/2026** estabeleceu a obrigatoriedade de utilização da NFS-e nacional a partir de **1º de novembro de 2026** para microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional que prestem serviços sujeitos a esse documento fiscal.

A emissão deverá ocorrer pelo Emissor Nacional, diretamente ou por integração tecnológica prevista na regulamentação.

As disposições específicas de CBS e IBS para esses contribuintes passam a produzir efeitos a partir de janeiro de 2027, inclusive quanto às informações e aos destaques fiscais cabíveis.

> **O que fazer:** verificar o emissor de notas, a integração com o sistema de gestão, o cadastro dos serviços e os procedimentos de contingência.

TRIBUTAÇÃO · CONTINUAÇÃO

Odontologia terá redução de alíquota

A **Lei Complementar nº 214/2025**, em seu art. 130 e Anexo III, prevê redução de 60% das alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre determinados serviços de saúde, incluindo serviços odontológicos classificados na NBS **1.2301.23.00**.

A regra equivale à aplicação de 40% da alíquota pertinente sobre os serviços efetivamente enquadrados, e não à redução automática de 60% de todos os tributos pagos pelo estabelecimento.

O resultado econômico depende do regime de tributação, das regras de transição, dos créditos admitidos e da classificação correta dos procedimentos.

Atividades estéticas que não preencham as condições legais para enquadramento como serviço de saúde não devem receber automaticamente o tratamento favorecido apenas por serem realizadas em uma clínica odontológica.



Split payment: implantação gradual

O mecanismo conhecido como *split payment* prevê a segregação e o recolhimento de tributos no momento da liquidação financeira de determinadas transações.

O Decreto nº 12.955/2026 regulamenta aspectos relativos à CBS, mas a aplicação operacional será desenvolvida em etapas e dependerá das condições regulamentares de cada modalidade.

Em 15 de outubro de 2026 começou a fase técnica de testes de integração da plataforma pública, em ambiente controlado, sem processamento definitivo de transações reais.

Não é correto presumir sua utilização obrigatória e universal no início de 2027, nem afirmar que o mecanismo se restringirá permanentemente a um único tipo de regime tributário.

Cinco perguntas para o contador

- ☐ **1.** A clínica já tomou sua decisão sobre o recolhimento de IBS e CBS para o primeiro semestre de 2027?
- ☐ **2.** A emissão da NFS-e nacional estará operacional em 1º de novembro?
- ☐ **3.** Quais serviços e procedimentos efetivamente se enquadram na redução de alíquotas destinada à saúde?
- ☐ **4.** Como as regras de crédito influenciam os contratos com convênios, empresas e outros clientes pessoas jurídicas?
- ☐ **5.** Qual é a diferença projetada entre os cenários tributários, considerando margem, preço final e fluxo de caixa?

FONTES OFICIAIS

Receita Federal — prazos do Simples Nacional para 2027

Lei Complementar nº 214/2025

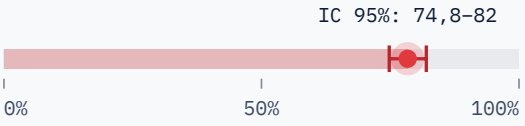
Receita Federal — obrigatoriedade da NFS-e nacional

Receita Federal — início dos testes do split payment

SAÚDE DO PROFISSIONAL

Distúrbios musculoesqueléticos: um problema persistente na profissão

78,4%
prevalência combinada



1,42
razão de chances entre mulheres

A prevalência combinada foi estimada em 78,4%, com intervalo de confiança de 95% entre 74,8% e 82%.

Uma revisão sistemática com meta-análise publicada por Chenna e colaboradores em 2022 reuniu 89 estimativas de prevalência provenientes de 88 publicações sobre distúrbios musculoesqueléticos entre profissionais da área odontológica.

A análise também encontrou maior frequência de distúrbios entre mulheres, com razão de chances de 1,42. Não foi observada tendência estatisticamente significativa de redução da prevalência ao longo do período investigado.

Esses resultados se referem a populações e métodos heterogêneos, incluindo diferentes profissionais e estudantes da área odontológica. Portanto, não constituem estimativa individual de risco nem representam especificamente a população brasileira.

Uma *umbrella review* de Jain e colaboradores, publicada eletronicamente em 2024 e incluída no volume de 2025 do *European Journal of General Dentistry*, destacou pescoço, costas, ombros, punhos e mãos como regiões frequentemente afetadas. Os autores também apontaram limitações importantes na qualidade da literatura disponível.

Três medidas práticas de organização ergonômica

As sugestões a seguir são orientações editoriais de ergonomia, e não intervenções cuja eficácia tenha sido demonstrada pelas revisões de prevalência mencionadas.

1. Ajuste integrado do campo operatório

A posição do paciente, o assento profissional e o campo visual devem ser organizados em conjunto, reduzindo a necessidade de flexão cervical e alcances excessivos.

2. Variação postural

Pequenas pausas e mudanças de posição entre procedimentos podem ser incorporadas à rotina, respeitando as condições de trabalho e eventuais limitações individuais.

3. Revisão das lupas

Distância de trabalho, altura e ângulo de declinação devem ser compatíveis com a postura utilizada, evitando adaptações que exijam flexão cervical prolongada.

SAÚDE DO PROFISSIONAL · CONTINUAÇÃO

MENSAGEM CENTRAL

A frequência dos distúrbios justifica atenção preventiva, mas a escolha de medidas de intervenção deve considerar avaliação ergonômica e evidências específicas, e não apenas estudos de prevalência.

REFERÊNCIAS

Chenna D et al. *Prevalence of musculoskeletal disorders among dental healthcare providers: A systematic review and meta-analysis.* F1000Research. 2022;11:1062. DOI: 10.12688/f1000research.124904.2.

Jain L et al. *Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Dental Professionals: An Umbrella Review.* European Journal of General Dentistry. 2025;14:1–10. DOI: 10.1055/s-0044-1790242.

05 · COMÉRCIO ODONTOLÓGICO

Três movimentos que merecem atenção das dentais

1. **A nova jornada trabalhista também afeta o varejo.** Empresas que funcionam aos sábados precisarão reexaminar a organização das equipes e o cumprimento dos repousos previstos na EC nº 141/2026. Não é possível presumir que toda loja necessitará de novas contratações; o impacto depende da escala e da operação.
2. **A revenda de dispositivos usados está em discussão regulatória.** A Consulta Pública Anvisa nº 1.423/2026 trata do enquadramento de dispositivos de uso único e reutilizáveis e contém propostas com possíveis repercussões sobre a comercialização de produtos usados. A existência da consulta não significa que toda revenda de equipamentos odontológicos seminovos esteja proibida.
3. **A reforma tributária poderá influenciar relações comerciais entre empresas.** A forma de recolhimento de IBS e CBS, os créditos admitidos e a classificação das operações poderão repercutir sobre preços e negociações com clínicas e outras pessoas jurídicas. Não existe efeito único e automático sobre a competitividade de todas as empresas do Simples.

O que fazer: revisar jornadas, manter inventário atualizado dos produtos comercializados e realizar simulações tributárias individualizadas.

PARA IMPRIMIR E PREENCHER

Sua equipe está preparada para a nova jornada?

A redução progressiva da jornada exige planejamento. Antes de definir uma escala 5×2, o gestor precisa conhecer a distribuição real das horas e o funcionamento de cada setor.

Preencha uma linha por empregado:

Colaborador	Função	Jornada atual (h/semana)	Dias atuais	Jornada proposta	Folgas propostas	Custo adicional estimado
Exemplo: Ana	*Recepção*	*44 h*	*Seg.–sáb.*	*A definir*	*A definir*	*A calcular*
	ASB					
	TSB					
	Recepção					
	Administrativo					

Como utilizar

Etapa 1 — Diagnóstico. Identifique horários de entrada, saída, intervalos e jornadas contratuais de todos os empregados.

Etapa 2 — Cobertura. Determine quais atividades precisam ser mantidas aos sábados e quais podem ser redistribuídas.

Etapa 3 — Cenários. Compare funcionamento em cinco dias, revezamento e cobertura complementar, respeitando os limites legais e coletivos.

Etapa 4 — Custos. Calcule eventuais contratações, horas extras e alterações operacionais. Não pressuponha custo adicional igual a zero.

Etapa 5 — Validação. Submeta a proposta à contabilidade e à assessoria trabalhista antes de executá-la.

A planilha é um instrumento de planejamento. Não substitui a conferência dos requisitos de jornada diária, compensação, intervalos e convenção coletiva.

Anvisa prepara revisão das regras de processamento de dispositivos médicos



A Anvisa abriu, em setembro de 2026, quatro consultas públicas relacionadas às regras de processamento e reúso de dispositivos médicos.

As **CPs nº 1.420 a 1.423/2026** discutem boas práticas em serviços de saúde, requisitos para empresas processadoras, validação de protocolos e enquadramento de produtos de uso único ou reutilizáveis.

PRAZO DE CONTRIBUIÇÃO

28/01/2027

A Agência recebe contribuições até **28 de janeiro de 2027**.

A discussão tem potencial impacto sobre fabricantes, importadores, distribuidores, empresas processadoras e estabelecimentos assistenciais, incluindo consultórios odontológicos.

Atenção: os documentos estão em consulta pública. Suas disposições não devem ser apresentadas como obrigações definitivamente aprovadas.

O que está em discussão?

A CP nº 1.423 contempla propostas relacionadas à identificação de dispositivos de uso único e reutilizáveis, adequação das instruções de uso, informações de processamento e critérios sanitários de regularização.

TEMA	PONTO EM DISCUSSÃO	REPERCUSSÃO POSSÍVEL
Enquadramento	Coerência entre classificação sanitária, indicação e rotulagem	Revisão de cadastros e portfólios
Uso único	Restrições e identificação dos produtos não destinados ao reúso	Impacto sobre determinados descartáveis
Reutilização	Informações e critérios de processamento	Exigência de documentação técnica
Validação	Demonstração da adequação dos protocolos	Revisão de processos e registros
Produtos implantáveis	Restrições específicas de reúso	Atenção a implantes e biomateriais
Produtos usados	Propostas de restrição à comercialização e importação	Possíveis efeitos sobre segmentos do mercado secundário

Continua na p. 15 →

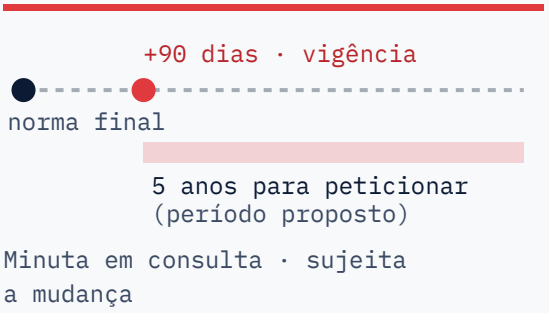
A discussão sobre restrições a dispositivos usados exige diferenciação entre produto destinado à implantação, instrumento reutilizável e equipamento durável. Não se deve concluir, sem análise da redação final e de seu campo de aplicação, que todo equipamento seminovo será alcançado da mesma forma.

Transição regulatória

A minuta da CP nº 1.423 prevê entrada em vigor 90 dias após a publicação de uma futura norma final e disposições transitórias para determinadas adequações.

Entre elas está um período proposto de cinco anos para peticionar modificações de regularização sanitária.

Esse prazo não constitui autorização geral para postergar qualquer obrigação nem garante que a redação será mantida após a consulta pública.



O que fabricantes e importadores devem fazer?

Mapear o portfólio por categoria sanitária, conferir registros e instruções de uso, reunir evidências de validação disponíveis e identificar pontos que demandem manifestação técnica durante a consulta.

A apresentação de contribuições deve conter fundamentação técnica e ser realizada pelos canais oficiais da Anvisa.

Leitura de cenário

Avaliação editorial: a revisão indica preocupação regulatória crescente com validação, rastreabilidade e consistência das informações fornecidas pelos responsáveis pelos produtos. Entretanto, ainda não é possível antecipar quais dispositivos da proposta serão aprovados, modificados ou rejeitados.

Para a indústria odontológica, o acompanhamento é especialmente relevante em linhas de instrumental, brocas, limas, sistemas cirúrgicos, dispositivos implantáveis e materiais utilizados em procedimentos de saúde.

Fonte oficial: AnvisaLegis — Consulta Pública nº 1.423/2026.

07 · ENCARTE RADAR GOV INDÚSTRIA · CONTINUAÇÃO

Também no radar da indústria

Instruções de uso: o carregamento obrigatório de instruções de uso no Repositório Documental de Dispositivos Médicos já encontra fundamento na RDC Anvisa nº 751/2022, especialmente no art. 33. Fabricantes devem observar a regulamentação vigente e as exigências aplicáveis a cada operação de regularização.

Dispositivos inovadores: em agosto de 2026, a Anvisa publicou o Edital de Chamamento nº 5/2026, destinado à seleção de até dez projetos de dispositivos médicos inovadores das classes de risco III e IV. A iniciativa contempla tecnologias com potencial de avanço assistencial, incluindo determinados biomateriais.

Fonte: Anvisa — edital para dispositivos médicos inovadores.

Na modalidade por assinatura, o Radar GOV Indústria poderá oferecer análise do impacto regulatório aplicada ao portfólio do cliente, mediante avaliação de seus documentos técnicos e registros sanitários.

Fontes, método e responsabilidade editorial

Esta edição utiliza prioritariamente fontes oficiais, incluindo:

- Presidência da República e legislação federal;
- Conselho Federal de Odontologia e seu sistema de atos normativos;
- Senado Federal;
- Receita Federal;
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- Artigos científicos identificados por DOI;
- Diretrizes clínicas da Federação Europeia de Periodontologia.

A análise distingue quatro categorias de informação:

normas vigentes	propostas e processos ainda não concluídos	resultados de pesquisa	interpretações editoriais

Estudos científicos são apresentados de acordo com os resultados e as limitações metodológicas identificados. Associações estatísticas não são tratadas automaticamente como evidência de causalidade ou justificativa suficiente para mudança de protocolo.

A cobertura regulatória reflete a situação das fontes consultadas até **17 de outubro de 2026**. Prazos administrativos, atos normativos e decisões judiciais podem sofrer alterações posteriores.

Este boletim possui finalidade informativa e não substitui avaliação clínica individualizada, orientação jurídica, contábil, trabalhista ou regulatória específica.

RADAR ODONTO
Informação verificada. Contexto científico. Aplicação responsável.

Edição nº 0 — Amostra editorial
17 de outubro de 2026
Eduardo Vieira Zanetti